



массы у мужчин

20.04.2026 / [Новости](#)



ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ПОТЕРЯ КОСТНОЙ МАССЫ У МУЖЧИН

Перевод: Филиппов Д. С.





меньшие практические последствия: боль, переломы, утрату мобильности и рост общей медицинской нагрузки.

Большинство прежних исследований этой темы касалось женщин и преимущественно антидепрессантов, особенно селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Авторы новой работы в *BJPsych Open* рассмотрели вопрос иначе: как психотропные препараты разных классов связаны с потерей костной массы у мужчин в длительном наблюдении.

Исследование основано на данных Geelong Osteoporosis Study, популяционной когорты из юго-восточной Австралии. В анализ вошли 940 мужчин старше 20 лет. Минеральную плотность костной ткани измеряли с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии в поясничном отделе позвоночника и общей области бедра на исходном этапе, а затем через 5 и 15 лет. Индекс массы тела рассчитывали отдельно, сведения об образе жизни и приёме лекарств собирали по самоотчётам, а расстройства настроения и тревожные расстройства определяли с помощью клинического интервью.

Всего 138 мужчин, то есть 14,7 % выборки, принимали психотропные препараты хотя бы в одной временной точке исследования. В эту группу вошли антидепрессанты, антипсихотики и противосудорожные препараты, которые в психиатрической практике также используются как нормотимики. Пользователей лития исключили из анализа из-за его потенциально положительного влияния на минеральную плотность костной ткани.

За медианный период наблюдения 13,2 года приём психотропных препаратов был связан со снижением минеральной плотности костной ткани как в поясничном отделе позвоночника, так и в области бедра. Эта связь сохранялась после статистической корректировки на возраст, индекс массы тела, курение, употребление алкоголя, физическую активность, применение препаратов, влияющих на костную ткань, социально-экономический статус, а также наличие расстройств настроения и тревожных расстройств в анамнезе.

Особенно важным оказался индекс массы тела. Потеря костной массы, связанная с психотропными препаратами, была заметна у мужчин на 25-м и 50-м перцентилях индекса массы тела, но не на 75-м перцентиле. Авторы интерпретируют это как



ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина, трициклических антидепрессантов и антипсихотиков статистически значимой связи обнаружено не было, но эти результаты нужно трактовать осторожно из-за очень малого числа участников в соответствующих подгруппах.

Противоэпилептические препараты принимали 32 мужчины, и их применение было связано со снижением минеральной плотности костной ткани в поясничном отделе позвоночника. Этот результат клинически важен, потому что препараты этой группы нередко используются длительно, в том числе у пациентов с биполярным расстройством, эпилепсией, болевыми синдромами и другими состояниями.

Авторы подчёркивают, что механизмы связи между психотропной терапией и потерей костной массы остаются недостаточно изученными. Возможные объяснения включают прямое влияние препаратов на ремоделирование костной ткани, опосредованные эндокринные и метаболические эффекты, а также повышение риска падений. При этом нельзя забывать и о самой психиатрической патологии: депрессия, тревожные расстройства и другие состояния могут быть связаны с воспалением, изменениями уровня кортизола, дефицитом витамина D, изменениями уровня половых гормонов, снижением физической активности, курением и употреблением алкоголя.

Почему это важно

Для клинической практики эта работа важна не тем, что она «доказывает вред» психотропных препаратов для костей. Наблюдательный дизайн не позволяет уверенно отделить действие лекарств от влияния заболевания, образа жизни и других факторов. Но исследование показывает, что костное здоровье у мужчин, длительно принимающих психотропные препараты, не должно оставаться вне поля зрения психиатра.

Особенно это касается пациентов с дополнительными факторами риска: низким или средним индексом массы тела, малоподвижностью, курением, злоупотреблением алкоголем, дефицитом витамина D, длительной терапией противоэпилептическими



Практический вывод не в том, чтобы избегать психотропных препаратов, когда они клинически необходимы. Скорее, речь о более зрелой модели долгосрочного ведения: если пациент годами получает психотропную терапию, особенно антидепрессанты или противоэпилептические препараты, врач должен думать не только о психическом состоянии и метаболизме, но и о профилактике остеопороза. Иногда это означает простой скрининг факторов риска, коррекцию дефицита витамина D, рекомендации по физической активности и, при наличии показаний, направление на денситометрию.

Ссылка на исследование

Weerasinghe DK, Stuart AL, Pasco JA, Mohebbi M, Hodge JM, Samarasinghe RM, et al. Psychotropic medication use and bone loss in men: longitudinal study. *BJPsych Open*. 2026;12(2):e89. doi:10.1192/bjo.2026.10985.

Перевод: Филиппов Д. С.

« Previous Post: Антипсихотики во время беременности не показали убедительной связи с нарушениями нейроразвития у детей

Next Post: У подростков с депрессией выделен профиль, связанный с особенно высоким риском самоповреждений »